内科学含诊断学 循环系统疾病

核心精讲·心包疾病

（性感认识：心界向两侧扩大首先考虑心包积液 VS 扩张型心肌病）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、急性纤维蛋白性心包炎

纤维素

心包腔渗出纤维素:急性期称为急性纤维蛋白性心包炎,慢性期称为缩窄性心包炎(纤维素没有完全溶解吸收,被肉芽组织机化)

1.病毒感染（最常见）、细菌感染、尿毒症等。若无法明确病因称为特发性急性心包炎（急性非特异性心包炎）

可以是柯萨奇B组病毒,既可导致病毒性心肌炎又可导致心包炎

2.**心包摩擦音（最有价值体征）**

①ttsx **粗糙搔/抓刮高频音**，双相或三相（心房收缩、心室收缩、心室舒张）

②与心搏一致：**屏气后仍有**、频率快

心脏靠近胸壁

③坐位前倾、**胸骨左缘 3-4 肋间**最明显

心脏裸区

④对比：

	心包摩擦音-心包炎	胸膜摩擦音-胸膜炎
性质	粗糙抓/搔刮音	
屏气后	仍有	消失
出现时机	与心搏一致（频率快），双相或三相	与呼吸一致（频率慢），吸气、呼气两相
听诊	坐位前倾、**胸骨左缘 3-4 肋间**最明显 《内科学》吸气明显、《诊断学》呼气明显	前下侧胸壁 吸气末或呼气初最明显
积液量增多	吸气时肺扩张→挤压心包→心包脏壁两层更容易摩擦	肺内气少,心脏靠近胸壁 可消失 脏壁分开

3.胸痛

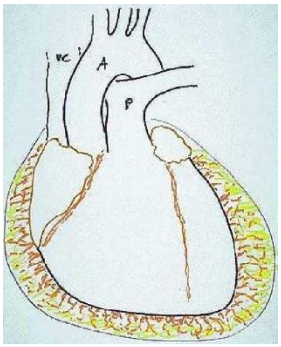
①胸骨后、心前区疼痛

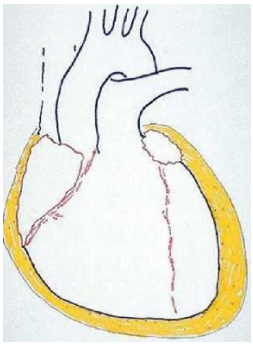
②锐痛，可为剧痛、刀割样痛 VS 冠心病:绞痛

③可放射至颈部、左肩、左臂、上腹部

④常因吞咽、咳嗽、深呼吸、变换体位加重

⑤治疗：NSAIDs





4.**心界不大或稍大**

心包腔内以渗出纤维素为主,不是渗出浆液为主

二、渗出性心包炎→心包积液→心脏压塞

①随积液量增多心包摩擦音、胸痛可消失，**呼吸困难突出** 压到支气管

②**心界向两侧扩大**

eg.呼吸系统中的严重肺气肿,左侧大量胸水,左侧大量气胸

心包腔压力↑→回心血量↓→搏出量↓→心率↑

③心尖搏动减弱、心率↑、**奇脉**、**脉压↓**

一个循环系统疾病,或多或少有搏出量↓→收缩压↓→脉压↓

④**体循环回流障碍**：颈静脉怒张、肝颈静脉回流征、双下肢水肿、胸腹水

⑤**心脏压塞 Beck 三联征：心音低弱遥远、血压↓、颈静脉怒张**（动低静高：动脉压低、静脉压高）

⑥**Ewart 征**：左肩胛下浊音、语颤增强、异常支气管呼吸音（类似胸腔积液压迫肺）water

⑦**Kussmaul 征**：吸气时颈静脉扩张更明显（Kussmaul 征还可见于缩窄性心包炎）BEcardiacK C:心脏

胸腔负压又吸气又吸血却无法回心

Kussmaul呼吸:酸中毒H^+刺激颈动脉体、主动脉体外周化学感受器,致呼吸加深加快

语颤增强、异常支气管呼吸音:实变(大叶性肺炎、肺梗死)、空洞、积液上方